جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : صفاء جمال أحمد ابراهيم
المحافظة : الشرقيه **الحي / المدينة :** هيا **العنوان :** خلوة دبوس
رقم البطاقة : 28711011309843 **رقم التليفون :** 01148342595 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-11-1987 **المهنة :** حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: صفاء جمال أحمد ابراهيم
National ID: 28711011309843

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL
EGYPTE

السيد الاستاذ الدكتور / مدير عام المجالس الطبيه المتخصصه

تحيه طيبه وبعد

نفيد علم سيادتكم علماً بأن السيد / صفاد نصار

صاحب الرقم القومى / ٢٨٧١١٠١١٣٠٩٨٤٣

رقم القرار / ٠٠٢٦٣٨٧٦٣٢٣

بأنه لم يتم استخدام قرار نفقه الدولة ولم يتم انشاء أى فاتوره اليكترونيه للقرار المطلوب الغاءه

وهذا للعلم والاحاطه

ولسيادتكم جزيل الشكر

الموظف المختص

مدير الإيرادات

مدير المستشفى

GRI-E
جوستاف روسي
تأسس عام ١٩٩٩ القاهرة مصر
جوستاف روسي - مصر ٢


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
صفاء
جمال احمد ابراهيم
خلوة دبوس
مركز ههيا - الشرقية
٢٨٧ ١١ ٠١ ١٣ ٠٩٨ ٤٣
LF5251065


٢٨٧١١٠١١٣٠٩٨٤٣
٢٠٢٥/٠٣
حاصلة على دبلوم زراعة
انثى
مسلمة
متزوجة
محمد احمد ابراهيم على الحنوانى
٨
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٦/٣٠

Name: صفاء جمال احمد ابراهيم	
MR. : 1957	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient was diagnosed in May 2023 with multifocal left breast cancer, with an asymmetrical density in the upper outer quadrant and a CT-stage of CT2 N1 M0. Imaging and axillary node sampling confirmed metastatic involvement of the left axillary lymph nodes (LT PATH AXILLARY LNS). A biopsy of a hemangioma in the upper-outer left breast was negative for malignancy. The patient was staged as CT2 N1 M0 and commenced neoadjuvant therapy with TCHP for 18 weeks, along with two cycles of PHESGO. A clip was inserted prior to definitive surgery. The patient subsequently underwent a right-sided whole-breast lumpectomy with sentinel lymph node biopsy, which demonstrated 0/4 positive nodes and a complete pathological response. The multidisciplinary team recommended a single radiation port and the continuation of 13 doses of trastuzumab for ongoing treatment. The patient has completed 18 weeks of TCHP and 2 cycles of PHESGO.

تحريرا في ,

التاريخ :	21-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

Patient Name	: الأستاذه / صفاء جمال احمد ابراهيم	Request No.	: 13006002
Patient No.	: 28711011309843	Request Date	: 25/11/2023
Path No.	: 4174/23	Verification Date	: 14/12/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 36 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data : Right breast cancer post NACT

Nature of the specimen : Right WLE&Right WLE of nipple and areola & Right SLN biopsy .

Gross Examination: .
Three specimens were received:
-first specimen :Right WLE specimen 5.5x5 x2 cm,covered with skin elipse measured 3x1 cm, cut section showed a greyish white firm tumour bed site measured 1.8 x1x1 cm , Away from
- second specimen fibrofatty tissue piece measured 4,5x4x3 cm, covered with skin 3.5x2.5 cm with intact nipple &areola. cut section revealed TBS was an ill defined rubbery greyish white tumour bed site measured 3x2x0.8 cm , 1 cm from least Superficial margin ,rest of specimen showed scattered grey white areas.
2-
3 - SLN biopsy : A fibrofatty tissue measured 4x3 cm enclosing 4 SLNs
• Frozen section: Free margins &free SLND (0/4)

Microscopic examination:
• Histological type: No viable tumor
• Angioinvasion: No
• Lymph node involvement: Free SLNs (0/4)
• Nipple &areola:Free
• Resection Margins: Free margins
• Histologic response to therapy: Pathologic complete response

Diagnosis:
Right WLE& Right SLN biopsy :
No viable tumor in a previously diagnosed invasive duct carcinoma

Verified by :
Dr.Heba Hasan

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	الأستاذه / صفاء جمال احمد ابراهيم	Request No.	: 13006002
Patient No.	:28711011309843	Request Date	: 25/11/2023
Path No.	:4174/23	Verification Date	: 14/12/2023
Sex	:Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	:36 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

- Free margins
- Free nipple &areola
- Free SLNs (0/4)
- Pathologic complete response
- Stage : ypT0, ypN0

Signature

Dr. Marwa Mahmoud
Dr.Heba Hassan

Verified by :
Dr.Heba Hasan

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Safaa Gamal Ahmed Ibrahim	Date : 06/03/2023
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 35 Year(s)
Medical ID:	29636

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. ***Chest:***

- Right breast UOQ irregular speculated mass lesion measuring 1.6 X 1.2 cm.
- Few bilateral scattered tiny pulmonary nodules reaching 3 mm.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. ***Abdomen and pelvis:***

- The liver is mildly enlarged with segment VIII hypodense focal lesion measuring 4 X 3.6 cm showing marginal nodular enhancement.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Bulky uterus with internal hypodense secretions and eft adnexal small marginally enhancing cystic lesion mostly functional.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- Minimal pelvic collection.

3. ***The scanned skeleton:***

DR.
Osama Abdalla Dawoud
Prof. of Diagnostic Radiology
Zagazig University
Fellowship - Karoliniska Institute
Stockholm - Sweden

دكتـــور
أسامه عبدالله داود
أستاذ الأشعة - طب الزقازيق
زميل جامعة كارولينسكا
استوكهولم - السويد

١٩٥٧

Patiant Name : ~~Safaa Gamal Ahmed~~

Dear Prof. Dr. : October 3, 2026

MRI LUMBOSACRAL SPINE:

- Abnormal bone marrow signal intensity seen involving almost all the examined vertebral bodies and multiple posterior neural elements, displayed low signal on T1WI and T2WI while high signal on STIR.
- Compression fracture of D12 vertebral body with convex posterior bulging, indenting the ventral aspect of the thecal sac, displayed low signal on T1WI, intermediate signal on T2WI.
- No significant disc bulge at the examined levels.
- Multi-level disc degenerative changes.
- Multiple Schmorl's nodes.
- No intra-medullary lesions.
- Normal caliber and signal intensity of the lower spinal cord.
- No paraspinal soft tissue masses.

N.B: LT ovarian complicated cyst measuring 71x52 mm.

IMPRESSION:

- Abnormal infiltrative osseous lesions with malignant compression fracture of D12 vertebra ..... Mostly metastatic deposits for metastatic workup.
- Spondylo-degenerative changes

Prof. Dr. Osama Dawoud

[[DOCTYPE:MRI]]
M.R.I

NILE SCAN & LABS

مركز النيل للأشعة و التحاليل

Name : Safa Jamal Ahmed Ibrahim
Branch : Dokki

Date : 04-08-2026
Medical No. : 432361

MRI OF THE CERVICAL SPINE AND NECK:-



TECHNIQUE:

Sagittal T1 and T2 Wis, DWIs and ADC
Axial T1, T2 and STIR WIs
Coronal T1 & T2 WIs

FINDINGS:

- Maintained cervical lordotic curve.
- Normal dimensions of the bony cervical spinal canal.
- Reduced bright T2 signal of the cervical discs denoting their degeneration.
- C3/4 down to C6/7 minimal central posterior disc protrusions are seen effacing the ventral subarachnoid CSF space and abutting the anterior aspect of the cord.
- Normal size and signal intensity pattern of the cord parenchyma.
- No evidence of intramedullary lesions.
- The CSF space around the cord is free. No intra-dural lesions seen.
- The bony structures show normal marrow signal intensity pattern.
- No Para spinal lesions seen.
- Normal MR appearance of both valeculae, pyriform fossae and aryepigolottic folds.
- Patent nasopharyngeal and oro-pharyngeal air column.
- Normal appearance of the parotid and submandibular salivary glands.
- Normal appearance of the thyroid gland.
- Normal appearance of the carotid sheath and its contents.
- Left maxillary sinusitis.

OPINION:

- **C3/4 down to C6/7 minimal central posterior disc protrusions.**

Much Obliged;
Dr.Marwa Elgawish, MSc, FEBR

NILE DIAGNOSTIC CENTER

DR.
Osama Abdalla Dawoud
Prof. of Diagnostic Radiology
Zagazig University
Fellowship - Karoliniska Institute
Stockholm - Sweden

دكتـــور
أسامه عبدالله داود
أستاذ الأشعة - طب الزقازيق
زميل جامعة كارولينسكا
استوكهولم - السويد

Zagazig Radiology and Interventional Center
مركز الزقازيق للأشعة والتداخل الإشعاعي
Mammography
X-Ray
Color Doppler
4D Ultrasound

١٩٥٧

Patiant Name : Safaa Gamal Ahmed

Dear Prof. Dr. : October 3, 2026

MRI LUMBOSACRAL SPINE:

- Abnormal bone marrow signal intensity seen involving almost all the examined vertebral bodies and multiple posterior neural elements, displayed low signal on T1WI and T2WI while high signal on STIR.
- Compression fracture of D12 vertebral body with convex posterior bulging, indenting the ventral aspect of the thecal sac, displayed low signal on T1WI, intermediate signal on T2WI.
- No significant disc bulge at the examined levels.
- Multi-level disc degenerative changes.
- Multiple Schmorl's nodes.
- No intra-medullary lesions.
- Normal caliber and signal intensity of the lower spinal cord.
- No paraspinal soft tissue masses.

N.B: LT ovarian complicated cyst measuring 71x52 mm.

IMPRESSION:

- Abnormal infiltrative osseous lesions with malignant compression fracture of D12 vertebra ..... Mostly metastatic deposits for metastatic workup.
- Spondylo-degenerative changes

Prof. Dr. Osama Dawoud

[[DOCTYPE:MRI]]
M.R.I

NILE SCAN & LABS

مركز النيل للأشعة و التحاليل

Name : Safa Jamal Ahmed Ibrahim
Branch : Dokki

Date : 04-08-2026
Medical No. : 432361



MRI OF THE CERVICAL SPINE AND NECK:-

TECHNIQUE:

Sagittal T1 and T2 Wis, DWIs and ADC
Axial T1, T2 and STIR WIs
Coronal T1 & T2 WIs

FINDINGS:

- Maintained cervical lordotic curve.
- Normal dimensions of the bony cervical spinal canal.
- Reduced bright T2 signal of the cervical discs denoting their degeneration.
- C3/4 down to C6/7 minimal central posterior disc protrusions are seen effacing the ventral subarachnoid CSF space and abutting the anterior aspect of the cord.
- Normal size and signal intensity pattern of the cord parenchyma.
- No evidence of intramedullary lesions.
- The CSF space around the cord is free. No intra-dural lesions seen.
- The bony structures show normal marrow signal intensity pattern.
- No Para spinal lesions seen.
- Normal MR appearance of both valeculae, pyriform fossae and aryepigolottic folds.
- Patent nasopharyngeal and oro-pharyngeal air column.
- Normal appearance of the parotid and submandibular salivary glands.
- Normal appearance of the thyroid gland.
- Normal appearance of the carotid sheath and its contents.
- Left maxillary sinusitis.

OPINION:

- **C3/4 down to C6/7 minimal central posterior disc protrusions.**

Much Obliged;
Dr.Marwa Elgawish, MSc, FEBR

NILE DIAGNOSTIC CENTER

Call Center 19656